Клинические рекомендации

Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J33.0** — Полип полости носа **J33.1** — Полипозная дегенерация синуса **J33.8** — Другие полипы синуса **J33.9** — Полип носа неуточненный
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Классификация 4

2.4 Шкала Lund–Kennedy 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Жалобы и анамнез 4

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы 5

3.2 Физикальное обследование 5

3.3 Инструментальные исследования 6

3.4 Лабораторные исследования 6

3.5 Иные исследования и консультации специалистов 6

4. Лечение 6

4.1 Кортикостероиды 6

4.2 Дополнительная терапия 7

4.3 Генно-инженерная биологическая терапия 7

4.4 Режимы дозирования 7

4.5 Хирургическое лечение 8

4.6 Послеоперационное ведение 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Показания к госпитализации 9

6. Источник и актуальность **9**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, данных осмотра и инструментальных исследований: передней риноскопии, эндоскопии полости носа и носоглотки, компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух.
- Препаратом выбора является мометазон в форме назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки курсом 3–6 месяцев. При отсутствии уменьшения симптомов в течение 5–6 недель рассматривается вопрос о хирургическом лечении.
- Системная антибактериальная терапия при полипозном риносинусите не рекомендуется.
- При тяжёлом течении, а также при сочетании с бронхиальной астмой рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (дупилумаб, омализумаб или меполизумаб).
- При неэффективности медикаментозной терапии или распространённом полипозе показано хирургическое лечение; оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В течение первого года после операции пациента осматривают каждые 3 месяца.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС) является фенотипом хронического риносинусита и представляет собой гетерогенное по этиологии и патогенезу хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП) продолжительностью более 12 недель, сопровождающееся ремоделированием слизистой оболочки, образованием и рецидивирующим ростом полипов.

Полипы носа представляют собой доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС характеризуется воспалением с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е (IgE). К нему относятся эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральная компартментная атопическая болезнь (CCAD), то есть изолированные полипозные изменения слизистой оболочки верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки носа у пациентов с установленной аллергией к ингаляционным аллергенам.

2.2 Этиология и патогенез

В развитии ПРС участвуют нарушения врождённого и адаптивного иммунитета, аллергия, генетически обусловленные заболевания (иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия), изменения внутриносовой анатомии, а также бактериальная, грибковая и вирусная инфекция. В совокупности или по отдельности эти факторы поддерживают хроническое воспаление слизистой оболочки носа, которое приводит к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом наиболее часто встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже парадоксальный изгиб средней носовой раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

2.3 Классификация

Единая классификация отсутствует. По клиническим и эндоскопическим данным выделяют три стадии: в первой стадии полипы ограничены средним носовым ходом, во второй выходят за его пределы, в третьей обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки применяется шкала Lund–Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оцениваются отдельно справа и слева, каждый признак от 0 до 2 баллов.

2.4 Шкала Lund–Kennedy

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Полипы	Полипы отсутствуют	Полипы в пределах среднего носового хода	Полипы распространяются за пределы среднего носового хода
Отёк	Отёк отсутствует	Умеренный отёк	Значительный отёк
Отделяемое	Отделяемое отсутствует	Прозрачное отделяемое	Густое гнойное отделяемое

Данные КТ оцениваются по шкале Lund–Mackay: снижение пневматизации каждой пазухи оценивается отдельно справа и слева в 0 баллов при отсутствии изменений, в 1 балл при частичном затенении и в 2 балла при тотальном затенении. Остиомеатальный комплекс оценивается в 0 баллов, если он интактен, и в 2 балла при его обтурации. Сумма для каждой стороны составляет от 0 до 12 баллов, общая сумма от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны в ней дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют. Остиомеатальный комплекс в таблице оценивается в 0, 1 или 2 балла, в тексте только в 0 или 2 балла. В строке «Общее количество баллов» справа указаны 0, 7 и 14, слева 0, 1 и 2, хотя согласно ключу под таблицей сумма составляет от 0 до 12 на сторону. Расчёт следует проводить по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

2.5 Клиническая картина

Пациентов беспокоят заложенность носа, слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки, ощущение тяжести и давления в области носа и в проекции околоносовых пазух, диффузная головная боль, снижение или отсутствие обоняния. В ряде случаев присоединяются жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость, недомогание, снижение работоспособности, сонливость. Необходимо оценить выраженность и продолжительность симптомов. При обострении симптомы усиливаются.

2.6 Жалобы и анамнез

Жалобы целесообразно разделять на группы. К назальным относятся затруднённое носовое дыхание, выделения из носа, снижение или отсутствие обоняния. К болевым относятся лицевая боль, ощущение распирания и давления в области лица, головная и зубная боль. К оро- и назофарингеальным относятся неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах. К системным относятся недомогание, утомляемость, снижение работоспособности. Такое разделение позволяет подтвердить диагноз, оценить степень тяжести и выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

При сборе анамнеза уточняются время и причины появления симптомов, последовательность их развития, выраженность и динамика, влияющие на них факторы, ранее проведённые обследования и лечение. Отдельно выясняются связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами, наличие непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), симптомов бронхиальной астмы, ПРС у близких родственников, одно- или двусторонний характер симптомов, рецидивирующие носовые кровотечения.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, данных физикального и инструментального обследования: передней риноскопии, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки, КТ околоносовых пазух.

3.1 Жалобы

У всех пациентов с подозрением на ПРС и с установленным диагнозом для подтверждения диагноза и оценки степени тяжести необходимо уточнить наличие двух или более жалоб, одной из которых является заложенность носа или выделения из носа; учитываются также боль и давление в проекции околоносовых пазух, снижение или отсутствие обоняния.

Степень тяжести заболевания у всех пациентов оценивается по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент оценивает выраженность симптома от 0 (симптом отсутствует) до 10 баллов (максимальная выраженность симптома). Лёгкому течению соответствуют 0–3 балла, умеренному 3–7 баллов, тяжёлому 7–10 баллов. Значимое влияние на качество жизни оказывают симптомы выраженностью 5 баллов и более.
Диагностическая специфичность повышается при сочетании двух или более субъективных симптомов с объективными признаками заболевания (данными эндоскопии носа и лучевых методов исследования).

> В комментарии к рекомендации указано, что оценка жалоб отличается высокой вероятностью ложноположительных заключений, однако приведены специфичность 89% и чувствительность 2%. Высокая специфичность, напротив, свидетельствует о малом числе ложноположительных результатов, поэтому значения, по-видимому, переставлены местами.

> Границы степеней тяжести по ВАШ в рекомендации перекрываются (0–3, 3–7 и 7–10 баллов); к какой степени относятся значения 3 и 7 баллов, не указано.

3.2 Физикальное обследование

Всем пациентам с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом для постановки диагноза и оценки особенностей течения необходим осмотр оториноларинголога.

Значение имеют пальпация и перкуссия в проекции околоносовых пазух, признаки назальной обструкции (затруднённое носовое дыхание, гнусавость), вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое, наличие полипов. При длительном течении и распространённом процессе полипы могут визуализироваться уже в преддверии носа, в ряде случаев отмечается расширение спинки наружного носа.

Передняя риноскопия, которую выполняют всем пациентам, позволяет оценить распространённость процесса и сопутствующую внутриносовую патологию.

Для определения локализации и распространённости изменений слизистой оболочки всем пациентам проводят эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки.

Эндоскопия позволяет дифференцировать ПРС от заболеваний со сходной симптоматикой: новообразований, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин. В сочетании с жалобами и анамнезом метод значительно повышает точность диагностики; специфичность и чувствительность метода составляют 84% и 66% соответственно.

3.3 Инструментальные исследования

КТ околоносовых пазух необходима каждому пациенту для оценки распространённости полипоза, состояния внутриносовых структур и костных стенок пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ может применяться конусно-лучевая томография носа и околоносовых пазух, поскольку она сопровождается меньшей лучевой нагрузкой и не приводит к превышению годовой дозы на одну анатомическую зону.

При подозрении на новообразование полости носа и околоносовых пазух дополнительно к КТ применяют магнитно-резонансную томографию (МРТ) околоносовых пазух.

Рентгенография околоносовых пазух дешевле и доступнее, однако при ПРС она малоинформативна по сравнению с КТ.

3.4 Лабораторные исследования

У всех пациентов операционный материал направляется на патолого-анатомическое исследование для дифференциации субтипов полипозного риносинусита.

Для выявления аллергического воспаления и выбора тактики лечения у всех пациентов выполняют цитологическое исследование отделяемого, отпечатков и мазков со слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

О выраженном аллергическом компоненте свидетельствует содержание эозинофилов более 10% в поле зрения.

3.5 Иные исследования и консультации специалистов

При подозрении на бронхиальную астму или атопию для уточнения диагноза и согласования лечения показана консультация пульмонолога и (или) аллерголога-иммунолога.

При подозрении на первичную цилиарную дискинезию исследуют скорость мукоцилиарного транспорта с помощью сахаринового теста.

---

4. Лечение

Медикаментозное и хирургическое лечение значительно и практически в одинаковой степени улучшают качество жизни при ПРС, что подтверждает приоритетное значение адекватной медикаментозной терапии.

4.1 Кортикостероиды

Кортикостероиды в форме назальных спреев применяют в качестве стартовой терапии при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также в пред- и послеоперационном периоде.

Предпочтение отдаётся препаратам с высокой топической активностью и низкой биодоступностью, поскольку они безопаснее при длительном применении. Назальные кортикостероиды уменьшают размеры полипов и заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

При отсутствии уменьшения симптомов в течение 5–6 недель применения мометазона рассматривается вопрос о хирургическом лечении.

Системные кортикостероиды используют при гиперреактивности бронхов, бронхиальной астме, непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов, рефрактерном течении ПРС, выраженной атопии, а также для уменьшения воспаления в пред- и послеоперационном периоде.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

4.2 Дополнительная терапия

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов применяют дополнительно к системным кортикостероидам или вместо них при их непереносимости, а также при рефрактерном к кортикостероидам течении ПРС.

Системная антибактериальная терапия при ПРС не рекомендуется, поскольку доказательств её эффективности недостаточно, тогда как риски (развитие резистентности микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта) реальны.

Применение макролидов обсуждается в связи с их иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, однако оптимальный препарат, доза и длительность терапии не определены, поэтому сделать однозначный вывод об их эффективности при ПРС не представляется возможным.

4.3 Генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой для повышения эффективности лечения и снижения риска рецидивов рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ): дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.

Препараты ГИБТ представляют собой рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, избирательно связывающие IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и хирургических вмешательствах в анамнезе при наличии трёх из следующих критериев: признаки Т2-воспаления (эозинофилы в ткани не менее 10 в поле зрения, или в крови не менее 150 клеток/мкл, или общий IgE не менее 100 МЕ/мл); потребность в системных кортикостероидах (2 курса и более за год или приём более 3 месяцев) либо противопоказания к ним; значимое снижение качества жизни (SNOT-22 не менее 40); аносмия по результатам исследования обоняния; бронхиальная астма, требующая регулярного применения ингаляционных кортикостероидов.

Ответ на терапию оценивается по пяти критериям: уменьшение размеров полипов, снижение потребности в системных кортикостероидах, улучшение качества жизни, улучшение обоняния и уменьшение влияния сопутствующих заболеваний. Наличие 4–5 критериев соответствует хорошему ответу, 2–3 критериев умеренному ответу, 0–1 критерия слабому ответу или его отсутствию. Эффективность оценивается через 6 месяцев и через год. При отсутствии ответа диагноз пересматривают, лечение прекращают и при необходимости переходят на другой препарат.

Лечение является длительным, при его прерывании возможен рецидив. Во время беременности препараты применяются только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В период грудного вскармливания решение о прекращении кормления или отмене препарата принимается с учётом пользы того и другого.

Решение о продолжении терапии принимается врачом с учётом тяжести заболевания и степени контроля обострений.

4.4 Режимы дозирования

Препарат	Доза
Мометазон, назальный спрей	По 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс 3–6 месяцев. После достижения эффекта — по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).
Преднизолон	Коротким курсом при недостаточном контроле симптомов назальными кортикостероидами: внутрь, в таблетках, 30–60 мг в сутки в течение 14 дней.

Препарат	Доза
Дупилумаб	Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. При пропуске введения лечение возобновляется как можно скорее; у пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Омализумаб	Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; доза и кратность введения определяются исходным уровнем IgE и массой тела и корректируются при значительном изменении массы тела.
Меполизумаб	Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно.

4.5 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению для восстановления носового дыхания прибегают при неэффективности медикаментозной терапии, а также при распространённом полипозе полости носа и околоносовых пазух.

Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ), включающая удаление полипозно изменённой слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, восстановление проходимости естественных соустий и коррекцию анатомических нарушений (как правило, септопластику и (или) резекцию носовых раковин, а также резекцию решётчатой буллы) под видеоэндоскопическим контролем.
В зависимости от выраженности изменений объём вмешательства может быть ограничен минимально инвазивными методиками, обеспечивающими дренирование и аэрацию околоносовых пазух.

Всем пациентам перед операцией рекомендованы кортикостероиды в форме назальных спреев, что позволяет уменьшить кровопотерю, улучшить обзор операционного поля и сократить продолжительность вмешательства.

Результат хирургического лечения во многом определяется предоперационной медикаментозной подготовкой.

4.6 Послеоперационное ведение

После любого хирургического вмешательства необходима комплексная реабилитация, направленная на восстановление носового дыхания и функции слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

Реабилитация включает охранительный режим продолжительностью 10–14 дней и более, санацию полости носа и околоносовых пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация–аспирация» в раннем послеоперационном периоде, бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина для профилактики образования синехий. При избытке вязкого отделяемого или наличии корок проводится орошение полости носа 0,9% раствором натрия хлорида, что улучшает контакт местных препаратов со слизистой оболочкой.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с ПРС подлежат диспансерному наблюдению у оториноларинголога для своевременного выявления ухудшения на фоне лечения или рецидива после операции и коррекции терапии.

Специфическая профилактика ПРС отсутствует. При применении назальных кортикостероидов в течение 6–12 месяцев в пред- и послеоперационном периоде у большинства пациентов отмечаются уменьшение выраженности воспаления, улучшение качества жизни, снижение частоты рецидивов и увеличение продолжительности ремиссии.

Кратность осмотров определяется индивидуально, однако в течение первого года после операции осматривают каждые 3 месяца. При рецидиве, требующем повторного хирургического вмешательства, и при подозрении на осложнённое течение показана КТ околоносовых пазух.

Пациентам с ПРС необходимо ежедневное применение назальных кортикостероидов, нередко в течение всей жизни с небольшими перерывами.

> Длительность применения назальных кортикостероидов в рекомендации указана по-разному: курс мометазона 3–6 месяцев (раздел 3.1), в пред- и послеоперационном периоде 6–12 месяцев (раздел 5), в разделе 7 ежедневно, нередко в течение всей жизни.

Наблюдение оториноларинголога должно быть систематическим, не реже одного раза в 3 месяца. Результат лечения зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от приверженности пациента лечению и выполнения им рекомендаций.

> В разделе 5 указано, что кратность обследований определяется индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца необходимы в течение первого года после операции. В разделе 7 и в информации для пациента указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Основной задачей является комплексное лечение, обеспечивающее контроль симптомов и улучшение качества жизни. В ряде случаев необходимы повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме показано также наблюдение аллерголога-иммунолога.

5.1 Показания к госпитализации

Обследование и лечение пациентов могут проводиться как амбулаторно, так и в условиях стационара.

Показанием к плановой госпитализации является проведение ФЭРСХ с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё при отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению. Плановая госпитализация в дневной или круглосуточный стационар возможна также для подбора и коррекции терапии и для проведения ГИБТ.

Выписка после операции возможна при удовлетворительном общем состоянии и улучшении или восстановлении носового дыхания.

Согласно алгоритму ведения пациента (приложение Б), после диагностики пациент с аллергией или бронхиальной астмой направляется к аллерголог-иммунологу или пульмонологу. При отсутствии показаний к операции наблюдение и лечение осуществляются амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, показана госпитализация в специализированный стационар для ФЭРСХ с последующим продолжением наблюдения и медикаментозного лечения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	`890_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не соответствует тексту раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют, остиомеатальный комплекс оценивается в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- В комментарии о жалобах указана высокая вероятность ложноположительных заключений, однако приведены специфичность 89% и чувствительность 2%; по смыслу значения переставлены.

- Границы степеней тяжести по ВАШ перекрываются: 0–3, 3–7 и 7–10 баллов.
- Длительность применения назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (раздел 3.1), 6–12 месяцев (раздел 5), ежедневно, нередко в течение всей жизни (раздел 7).
- Кратность наблюдения в разделе 5 определяется индивидуально, с осмотрами каждые 3 месяца в течение первого года после операции; в разделе 7 указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.
- Назальные кортикостероиды перед операцией рекомендованы дважды с разными уровнями: в разделе 3.1 УУР С, УДД 5, в разделе 3.2 УУР В, УДД 2.
- В оглавлении подраздел «Физикальное обследование» пронумерован как 2.1 вместо 2.2, а приложение А3.1 указано на странице 30, то есть раньше приложения А3 на странице 31.